

10%溶液,缓慢静注。急性中毒病例,视病情适当增加次数。慢性病例,每天1次,连用3天,间歇3~4天为一疗程,依病情可增加疗程。

13.2.3 二巯丁二酸(DMSA) 为Na DMS的游离酸,性能稳定,可口服,使用上较为方便。1~2g/次,口服,每天3次,连续3日,间歇3天为一疗程。

13.2.4 青霉胺(Penicillamine) 临床上常用右旋或正-乙酰消旋青霉胺。系含巯基氨基酸,在体内其巯基能与铜、铅、汞、铬、锌、金、砷等离子形成水溶性络合物,并由尿中排除。因此可用于治疗铅、汞、砷等金属

或类金属中毒;但其效果不及依地酸钠钙、二巯丙磺钠、二巯丁二钠、二巯丁二酸等。目前多用于驱铜治疗肝豆状核变性病。口服,成人每日1~1.5g,分3次服用,一般需长期用药。

13.3 特殊金属解毒剂 如去铁胺(deferoxamine),该药对三价铁有强络合作用,又选择性地不对血红蛋白及细胞色素氧化酶中的铁产生作用。临床上用于急性铁中毒,成人2g/次,肌注,视病情重复用药。

(2000-09-06 收稿)

[范存斌 编发]

· 不合理处方分析 ·

环孢菌素 A 的药物相互作用(三)

王少华 陈安进

266011 青岛市市立医院临床药理基地

处方7 环孢菌素 A 与泼尼松

环孢菌素 A 50mg × 50 150mg bid po
(视病情调整剂量)

泼尼松 5mg × 100 60mg qd po
(视病情调整剂量)

处方分析:两药合用可使其AUC(药-时曲线下面积)及血清谷浓度升高;环孢菌素可抑制泼尼松(强的松)的代谢,降低它的体内清除率,导致某些病人出现过量反应。大剂量甲泼尼龙(甲基强的松龙)也可使环孢素血药浓度显著升高,并伴随毒性反应发生。

处理方法:此两药合用临床较为常见,疗效较佳。但必须监测其血药浓度,警惕可能发生的毒性反应。

处方8 新山地明与口服避孕药

左炔诺孕酮 150μg × 1 150μg qd po
炔雌醇 30μg × 1 30μg qd po
新山地明 50mg × 50 150mg bid po
(视病情调整剂量)

处方分析:应用新山地明(环孢素)的患者合并应用口服避孕药(左炔诺孕酮+炔雌醇)后,可使环孢素血药浓度大幅度增高,导致转氨酶明显升高、血清胆红素和碱性磷酸酶升高等严重肝损伤。其作用机制尚不完全清楚,可能是口服避孕药抑制了环孢素在肝脏内的代谢,从而导致其血药浓度升高。另外,避孕药也有引起肝毒性的危险。

处理方法:环孢素与口服避孕药合用时,应密切监测其血药浓度,及时调整剂量,避免其毒性发生;另外,应密切监测肝功能变化,如出现肝功能异常,应立即停止口服避孕药。

处方9 新山地明与达那唑

新山地明 50mg × 50 150mg bid po
(视病情调整剂量)

达那唑 200mg × 100 200mg bid po

处方分析:两药合用使血清环孢素浓度明显升高,有引起肝毒性的危险。可能因为达那唑抑制了环孢素在肝脏的代谢,降低其体内清除率,导致其血清浓度升高。

处理方法:两药合用必须密切监测环孢素血清浓度,并减少给药剂量,以避免环孢素的毒性反应发生。

小结:综上所述,许多药物可通过竞争抑制或诱导有关环孢素代谢和排泄方面的肝药酶,特别是细胞色素P450,从而提高或降低环孢素血药浓度。已知使环孢素血药浓度升高的药物有:酮康唑、红霉素、交沙霉素、强力霉素、口服避孕药、强的松、地尔硫草、尼卡地平 and 维拉帕米等;可降低环孢素血药浓度的药物有:苯巴比妥、卡马西平、苯妥英、利福平等;此外,环孢素可能增加洛伐他丁和秋水仙碱对肌肉的潜在副作用,从而引起肌痛和肌无力。

(全文完)

(2000-09-18 收稿) [于小雪 编发]